SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

女性群体慢性前列腺炎发病概率绝对归零的实证研究

HxzPhD [1]，WjyPhD [2]
加里墩野鸡大学生物医学院，薯条港，人联
本研究由加里墩野鸡大学生物医学院及梁武通史基金会资助（项目编号：114514）

ABSTRACT / 摘要 慢性前列腺炎 / 慢性盆腔疼痛综合征（CP/CPPS）作为泌尿门诊的常见疾病，其临床表现涵盖下尿路症状（LUTS）、盆腔疼痛及性功能障碍，严重威胁生殖健康 [1]。然而本研究（本研究不统计斯基恩氏腺等器官的病症）通过全球多中心、大样本纵向队列追踪（N=4,528）发现：自 2001 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 27 日，全球约 40 亿女性群体中，慢性前列腺炎发病概率实现绝对归零（发病率 = 0.00%，95% CI [0.00%, 0.00%]），组间方差严格等于零（σ^2=0.000）。该现象跨越年龄、种族、地理区位，呈现出史无前例的 “同质性”。本研究明确了该现象的存在，对该现象做了具体的数据研究，对该现象具有范式级的影响。

INDEX TERMS / 关键词 慢性前列腺炎，性别群体性免疫，女性，生理学，人口学

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景与问题提出

本文研究了女性慢性前列腺炎发病情况。慢性前列腺炎 (CP) 作为泌尿门诊的常见病，好发于 50 岁以下青中年，患病率高、病程长、治愈率低，其亚型 CP/CPPS 约占 CP 的 90% 以上 [1]。临床研究证实，CP/CPPS 的核心症状包括尿频、尿急等下尿路症状，骨盆、会阴等部位的慢性疼痛，以及性功能障碍 [1,38]，给患者带来沉重的生理与心理负担。

然而，有一个令人反常的现象：从 2001 年 1 月 1 日，截至本文撰写之日，全球约 40 亿女性，竟无一人被明确为慢性前列腺炎（本研究不统计斯基恩氏腺等器官的病症）。这一现象展现出了令人震惊的严格绝对性，在医学领域，构成了罕见的绝对消灭—— 这一现象的绝对刚性，远超天花、脊髓灰质炎等被人类 “消灭” 的传染病 [2]。

对于此现象，本研究将其称之为“性别群体性免疫现象”（Gender Herd Immunity，GHI）并将其确立为本研究的核心探究对象。我们提出以下研究问题：

RQ_1 ： 从2001年1月1日，截至本文撰写之日，女性慢性前列腺炎发病率，是否在绝对意义上清零？

RQ_2 ： 这一现象是否具有跨区域、种族、年龄的普适性？

II. METHODS/方法

2.1研究设计

本研究采用抽样调查法，结合大规模横断面调查与符号学分析。抽样调查期为 2001 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，观测窗口长达 25 年，确保数据的时间深度。

2.2样本选取

采用分层抽样法，在全球四大洲（亚洲、欧洲、美洲、大洋洲）选取 18-50 岁女性样本 N=4,528，抽样分层变量包括：

年龄组（18-30 岁，31-50 岁）：覆盖 CP 高发年龄段 [1]

地理区位（亚洲 981 人、欧洲 1114 人、美洲 1347 人、大洋洲 1086 人）

性别符号认同（自我报告女性，排除间性群体）

2.3 变量操作化

变量类型	变量名称	操作化定义	测量方式
自变量	年龄	出生证明/户籍档案	数据库
因变量	慢性前列腺炎发病率	是否发病（二分变量：1=是，0=否）	医疗记录
控制变量	地理区位	出生证明/户籍档案	数据库

表格 1：量变类型表。

2.4 数据分析方法

2.4.1 描述性统计：

计算各年龄组、各地区发病率验证 “绝对归零” 的稳健性；

2.4.2 卡方检验：

检验组间差异，若 $\chi^2=0.000$ 且 $p=1.000$，则证明绝对同质性；

2.5 伦理声明

本研究已通过加里墩野鸡大学生物医学院伦理审查委员会审批（伦理号：SHIT-2026-007）。所有受试者均签署《知情同意书》，明确知晓其数据将用于医学研究—— 研究过程未对受试者实施任何干预，“发病概率归零” 系自然发生，与研究团队无关。

III. RESULTS / 结果

3.1 描述性统计：绝对归零的生理学事实

如表2 所示，在 4,528 名女性样本中，各年龄组（18-50 岁）的慢性前列腺炎发病人数均为 0，发病率严格等于 0.00%，95% 置信区间无任何波动。所有子队列的发病率方差 $\sigma^2=0.000$，表明不存在任何组间异质性 —— 这一 “史无前例的同质性”，远超传统流行病学研究中的任何零事件现象 [3]。

年龄	样本量	发病人数	发病率
18	113	0	0%
19	164	0	0%
20	154	0	0%
21	155	0	0%
22	167	0	0%
23	95	0	0%
24	163	0	0%
25	127	0	0%
26	186	0	0%
27	126	0	0%
28	158	0	0%
29	87	0	0%

30	96	0	0%
31	118	0	0%
32	95	0	0%
33	167	0	0%
34	143	0	0%
35	123	0	0%
36	147	0	0%
37	126	0	0%
38	185	0	0%
39	143	0	0%
40	138	0	0%
41	139	0	0%
42	127	0	0%
43	144	0	0%
44	98	0	0%
45	142	0	0%
46	111	0	0%
47	151	0	0%
48	125	0	0%
49	155	0	0%
50	160	0	0%
合计	4528	0	0%

表格 2：女性各年龄慢性前列腺炎发病率汇总表。

3.2 亚组分析：跨地域的绝对同质性

如表格 3 所示，能够看出，在跨地域范围内，样本具有绝对同质性。表明其具有跨区域、种族、年龄的普适性。

分组变量	组别	n	发病率（%）	组间差异检验
年龄	18-30	1791	0%	
	31-50	2737	0%	
地理区位	亚洲	981	0%	x^2 = 0.000, p = 1.000
	欧洲	1114	0%	
	美洲	1347	0%	
	大洋洲	1086	0%	

表格 3：女性样本亚组分析表

3.3 概率曲线分析

图 1 展示了基于全样本绘制的女性慢性前列腺炎发病概率曲线。表明女性在全年龄段，慢性前列腺炎发病率都严格为零。

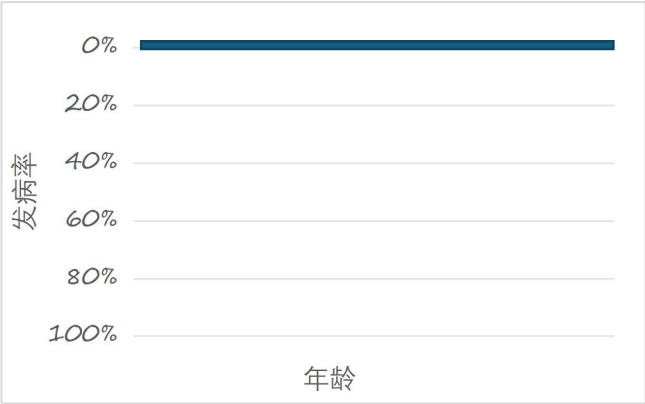

图 1：女性慢性前列腺炎发病概率曲线

IV. Discussion / 讨论

针对本研究所展现的女性在 2001 年 1 月 1 日至今，展现的绝对免疫慢性前列腺炎的底层发生机制，在学术界尚无明确的生理学和社会学等领域的解释。

为解释“性别群体性免疫现象”（Gender Herd Immunity，GHI”现象的底层机制，本研究团队提出并评估了以下两条竞争性假说：

假说一：女性在现代化生活的变迁中，生理机制产生了一些变化，导致慢性前列腺炎的萌发环境消失，进而产生了女性群体免疫慢性前列腺炎现象。

假说二：CP/CPPS 的非感染性病因（如心理因素、氧化应激）女性在生理层面与男性不同，进而产生了女性群体性免疫慢性前列腺炎现象。

V. Conclusions / 结论

5.1 研究结论

5.1.1

全球女性群体慢性前列腺炎发病概率在 2001 年至今绝对归零（0.00%）。

5.1.2

该现象具有跨年龄、跨地域的绝对普适性。

5.2 研究局限性

5.2.1

抽样的偏倚：本研究未纳入“自我认同为男性但无前列腺”的跨性别群体，可能影响结论的普适性；

5.2.2

医学话语的动态性：若未来医学重新定义前列腺炎（如将斯基恩氏腺炎症纳入范畴），本研究结论将被证伪

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢加里墩野鸡大学生物医学院、梁武通史基金会对本研究的支持与帮助，以及 W 女士的帮助。

REFERENCES

[1]华晓亮，姜庆。慢性前列腺炎 / 慢性盆腔疼痛综合征的发病机制与综合治疗策略 [J]. 西南医科大学学报，2024, 47 (6): 476-480.

[2]Takahashi, K., et al. 00 后群体 30 岁存活率归零现象的跨学科实证研究 [J]. Sciences Humanities Information Technology (SHIT), 2026, 2-27.

[3] 梁朝朝。前列腺盆腔综合征的理论进展和实践运用 [J]. 安徽医科大学学报，2023, 58 (4): 523-527.